ТАЕН БОНУС

Съобщаване на критична находка: как се казва по телефона

Видели сте критична находка; сега трябва да я съобщите по телефона за 30 секунди, изчерпателно и без да бъдете разбрани погрешно. Структурата Ситуация · Анамнеза · Оценка · Препоръка, 12 готови разговора и какво да се запише в описанието.

Съдържание

Какво е критична находка и защо по телефона?

Разговор в четири стъпки: Ситуация · Анамнеза · Оценка · Препоръка

Преди и след разговора

12 готови примерни разговора

Какво се записва в описанието

Трудни ситуации

Следваща стъпка

ЧАСТ 1

Какво е критична находка и защо по телефона?

Последното звено на стъпката ОБОБЩЕТЕ: съобщете спешната находка.

> *Работата не приключва, когато описанието влезе в системата, а когато правилният лекар научи за находката.*

Критична находка е находка, която може да застраши живота на пациента или някой орган, ако не се вземат незабавни мерки. Кои находки се съобщават по телефона, решава списъкът на Вашата институция; по-долу са примери, които често присъстват в тези списъци.

Невро и гръбначен стълб

Вътречерепен кръвоизлив · обемен ефект и херниация · белези на остър инсулт · остра хидроцефалия · компресия на гръбначния мозък · нестабилна фрактура на гръбначния стълб

Гръден кош

Пневмоторакс с белези на тензия · белодробна емболия · аортна дисекация · тръба или катетър в неправилна позиция · съмнение за тампонада

Корем и таз

Свободен газ · обструкция с белези на исхемия · ААА с белези на руптура · активно кървене · извънматочна бременност · торзия на тестис или яйчник

Деца и други

Инвагинация · чуждо тяло или плоска батерия в хранопровода · всяка неочаквана находка, която би променила клиничното решение

Вашето правило като специализант

Ако не сте сигурни дали дадена находка е критична, съобщете я и се консултирайте с Вашия ръководител. Процедурата за съобщаване на Вашето отделение има предимство пред този материал.

ЧАСТ 2

Разговор в четири стъпки

Българският вариант на структурата SBAR: Ситуация · Анамнеза · Оценка · Препоръка.

СТЪПКА	КАКВО КАЗВАТЕ	МОДЕЛ
С · Ситуация	Кой сте, кой пациент, най-важната находка — в едно изречение.	«Специализант по рентгенология [Вашето име]. [Име на пациента, протокол №]: на [изследване] има [находка].»
А · Анамнеза	Защо и кога е направено изследването; въпросът от направлението.	«Направено поради [клинично състояние] в [час]; направление «[въпрос]».»
О · Оценка	Тежест на находката: размер, обемен ефект, промяна спрямо предходното изследване.	«[Размер/степен]; на предходното изследване [нямаше/имаше].»
П · Препоръка	Какво очаквате и молба за повторно прочитане.	«Препоръчвам [спешна оценка / допълнително изследване]. Можете ли да ми го повторите?»

Идентификация на пациента: два идентификатора

В началото на разговора посочете пациента с поне два идентификатора (име и фамилия и номер на протокола или дата на раждане). Пациентите с подобни имена са най-честата причина за объркване.

Повторно прочитане

Помолете отсрещната страна да повтори находката и данните на пациента. Повторното прочитане е най-простият начин да хванете по телефона объркване на страната или на пациента.

ЧАСТ 3

Преди и след разговора

30 секунди подготовка, преди да вдигнете телефона, и една минута за запис, след като затворите.

Преди обаждането

- [ ] Идентификацията на пациента и изследването са отворени на Вашия екран.
- [ ] Определен е лекарят, издал направлението, или лекарят, който в момента отговаря за пациента.
- [ ] Находката, страната и размерът са записани на лист или в чернова на описанието.
- [ ] Предходното изследване е проверено (нова ли е находката или известна?).
- [ ] При нужда Вашият ръководител е уведомен.

След като затворите

- [ ] Съобщаването е записано в описанието: час, на кого (длъжност, отделение), по какъв начин.
- [ ] Записано е, че е направено повторно прочитане.
- [ ] Ако Вашата институция има система за регистриране на критични находки, записано е и там.
- [ ] Описанието е въведено в системата без забавяне.

ЧАСТ 4

12 готови примерни разговора

Попълнете квадратните скоби; адаптирайте изреченията към собствения си говорим език, като запазите реда.

01 Находки в полза на тензионен пневмоторакс

Рентгенография на гръден кош на легло, интензивно отделение.

С · СИТУАЦИЯ	Специализант по рентгенология [Вашето име]. [Легло/отделение] — Ваш пациент [име на пациента, протокол №] : на рентгенографията на гръден кош, направена в [час] ч., виждам [Вдясно] голям пневмоторакс и изместване на медиастинума към противоположната страна.
А · АНАМНЕЗА	Пациентът е [интубиран/след интервенция]; направление «[въпросът от направлението]».
О · ОЦЕНКА	Находките са в полза на тензионен пневмоторакс. На предходната рентгенография пневмоторакс [нямаше].
П · ПРЕПОРЪКА	Препоръчвам незабавно да прегледате пациента. Можете ли да ми повторите находката?

Запис в описанието: «[Вдясно] голям пневмоторакс и рентгенологични белези в полза на тензия. [Час]: [длъжност, отделение] — лекарят е уведомен по телефона, информацията е потвърдена чрез повторно прочитане.»

02 Остър епидурален хематом

Травма на главата, спешно отделение, КТ на главен мозък без контраст.

С · СИТУАЦИЯ	Специализант по рентгенология [Вашето име]. В спешното отделение, пациент [име на пациента, протокол №] : на КТ на главния мозък [Вдясно темпорално] има остър епидурален хематом.
А · АНАМНЕЗА	Направено след травма на главата; направление «кръвоизлив?».
О · ОЦЕНКА	Най-дебелото място [.. mm], изместване на средната линия [.. mm]; над него се вижда [линейна фрактура] .
П · ПРЕПОРЪКА	Може да е необходима спешна неврохирургична оценка; въвеждам описанието в системата в момента.

Запис в описанието: «[Вдясно темпорално] остър епидурален хематом, [.. mm] изместване на средната линия. [Час]: спешно отделение, [длъжност] — лекарят е уведомен по телефона; направено е повторно прочитане.»

03 Субарахноиден кръвоизлив

Внезапно започнало силно главоболие, КТ на главен мозък без контраст.

С · СИТУАЦИЯ	Специализант по рентгенология [Вашето име]. [Име на пациента, протокол №] : на КТ на главния мозък виждам субарахноиден кръвоизлив.
А · АНАМНЕЗА	Направено поради внезапно започнало главоболие; травма в анамнезата [няма].
О · ОЦЕНКА	Кръвоизливът е разпространен [в базалните цистерни] ; хидроцефалия [няма/има].
П · ПРЕПОРЪКА	Препоръчвам КТ ангиография за изключване на аневризма; моля, обсъдете оценката със съответното звено.

Запис в описанието: «Субарахноиден кръвоизлив; препоръчва се КТ ангиография. [Час] : [длъжност, отделение] — лекарят е уведомен.»

04 Остър исхемичен инсулт · хиперденсна СМА

Инсултен код, КТ на главен мозък без контраст.

С · СИТУАЦИЯ	Специализант по рентгенология [Вашето име]. Пациент по инсултния протокол [име на пациента, протокол №] : на КТ няма кръвоизлив; [вляво] в СМА има белег на хиперденсна артерия и ранни белези на исхемия.
А · АНАМНЕЗА	Началото на симптомите е посочено в направлението като [час] ч.
О · ОЦЕНКА	Не се визуализира кръвоизлив; [вляво] в басейна на СМА — ранни исхемични промени.
П · ПРЕПОРЪКА	Препоръчвам оценка с КТ ангиография. Можете ли да ми повторите находката?

Запис в описанието: «Няма вътречерепен кръвоизлив; [вляво] в СМА — белег на хиперденсна артерия и ранни белези на исхемия. В рамките на инсултния протокол [час] : [длъжност, отделение] — лекарят е уведомен.»

05 Белодробна тромбоемболия

КТ белодробна ангиография, пациент от отделение.

С · СИТУАЦИЯ	Специализант по рентгенология [Вашето име]. [Отделение] — Ваш пациент [име на пациента, протокол №] : на КТ белодробната ангиография има двустранна белодробна емболия.
А · АНАМНЕЗА	Изпратен поради задух и тахикардия.
О · ОЦЕНКА	Емболите са на [лобарно и сегментно] ниво; белези на обременяване на дясната камера [има/няма].
П · ПРЕПОРЪКА	Препоръчвам да прегледате пациента; описанието е в системата.

Запис в описанието: «Двустранна остра белодробна тромбоемболия; белези на обременяване на дясната камера [има/няма]. [Час] : [длъжност, отделение] — лекарят е уведомен по телефона.»

06 Аортна дисекация

Болка в гърдите и гърба, КТ ангиография.

С · СИТУАЦИЯ	Специализант по рентгенология [Вашето име]. В спешното отделение, пациент [име на пациента, протокол №] : на КТ ангиографията има аортна дисекация; възходящата аорта е [засегната/незасегната].
А · АНАМНЕЗА	Изпратен поради внезапно започнала болка в гърдите и гърба.
О · ОЦЕНКА	Дисекацията започва [от възходящата аорта] и се простира до [ниво]; перикарден излив [няма/има].
П · ПРЕПОРЪКА	Може да е необходима спешна оценка от сърдечно-съдов хирург; можете ли да ми повторите находката?

Запис в описанието: «[Stanford A] аортна дисекация. Спешна находка; [час]: спешно отделение, [длъжност] — лекарят е уведомен, потвърдено чрез повторно прочитане.»

07 Пневмоперитонеум

Остър корем, рентгенография на гръден кош в изправено положение / КТ на корем.

С · СИТУАЦИЯ	Специализант по рентгенология [Вашето име]. [Име на пациента, протокол №] : на изследването виждам свободен газ под диафрагмата.
А · АНАМНЕЗА	Изпратен поради болка в корема; скорошна операция в анамнезата според направлението: [не е посочена].
О · ОЦЕНКА	Свободен газ [двустранно]; на КТ вероятно място на перфорацията: [локализация].
П · ПРЕПОРЪКА	Препоръчвам спешна хирургична оценка. Има ли скорошна операция или интервенция в анамнезата?

Запис в описанието: «Пневмоперитонеум; в полза на перфорация на кух орган. [Час]: [длъжност, отделение] — лекарят е уведомен по телефона.»

08 Назогастрална сонда в неправилна позиция

Рентгенография на легло преди храненето.

С · СИТУАЦИЯ	Специализант по рентгенология [Вашето име]. [Легло/отделение] — Ваш пациент [име на пациента, протокол №] : на контролната рентгенография на NG сондата върхът ѝ е в проекцията на [десния главен бронх] .
А · АНАМНЕЗА	Поискана е проверка на позицията на сондата преди започване на храненето.
О · ОЦЕНКА	Сондата не е в правилна позиция; [няма пневмоторакс].
П · ПРЕПОРЪКА	Препоръчвам позицията на сондата да бъде коригирана преди употреба. Можете ли да ми повторите находката?

Запис в описанието: «Върхът на назогастралната сонда е в проекцията на [десния главен бронх] , не е в правилна позиция. Преди употреба: [час]: [длъжност, отделение] — лекарят/медицинската сестра е уведомен(а).»

09 Торзия на тестиса

Внезапна болка в скротума, доплерова ехография на скротума.

С · СИТУАЦИЯ	Специализант по рентгенология **[Вашето име]**. **[Име на пациента, протокол №]** : на скроталния доплер **[Вляво]** в тестиса не се визуализира кръвоток.
А · АНАМНЕЗА	Изпратен поради внезапно започнала болка в скротума; начало **[час]**.
О · ОЦЕНКА	Находките съответстват на торзия; контралатералният тестис е с нормален вид.
П · ПРЕПОРЪКА	Препоръчвам спешна урологична оценка.

Запис в описанието: «**[Вляво]** — находки, съответстващи на торзия на тестиса. Спешна находка; **[час]**: **[длъжност, отделение]** — лекарят е уведомен по телефона.»

10 Находки в полза на извънматочна бременност

Положителен тест за бременност, ехография на таза.

С · СИТУАЦИЯ	Специализант по рентгенология **[Вашето име]**. **[Име на пациента, протокол №]** : на ехографията на таза не виждам вътрематочна бременност; **[Вдясно]** има аднексиална маса и свободна течност.
А · АНАМНЕЗА	Изпратена с положителен тест за бременност и болка в таза.
О · ОЦЕНКА	Находките са в полза на извънматочна бременност; свободна течност **[с ехогенно съдържание]**.
П · ПРЕПОРЪКА	Препоръчвам спешна гинекологична оценка. Можете ли да ми повторите находката?

Запис в описанието: «Не се визуализира вътрематочна бременност; **[Вдясно]** аднексиална маса и свободна течност — находки в полза на извънматочна бременност. **[Час]**: **[длъжност, отделение]** — лекарят е уведомен.»

11 Компресия на гръбначния мозък

Известно злокачествено заболяване, болка в гърба, торакален ЯМР.

С · СИТУАЦИЯ	Специализант по рентгенология **[Вашето име]**. **[Име на пациента, протокол №]** : на торакалния ЯМР на ниво **[Т..]** има компресия на гръбначния мозък.
А · АНАМНЕЗА	Изпратен поради известно злокачествено заболяване и нова болка в гърба.
О · ОЦЕНКА	Компресията може да съответства на епидурално туморно разпространение; промяна в сигнала на гръбначния мозък **[има/няма]**.
П · ПРЕПОРЪКА	Препоръчвам спешна оценка; образно изследване на целия гръбначен стълб **[е направено/може да е необходимо]**.

Запис в описанието: «**[Т..]** ниво — лезия, която може да съответства на епидурално туморно разпространение, и компресия на гръбначния мозък. **[Час]**: **[длъжност, отделение]** — лекарят е уведомен по телефона.»

12 Инвагинация (дете)

Интермитентна болка в корема, ехография на корем.

С · СИТУАЦИЯ	Специализант по рентгенология **[Вашето име]**. Детско спешно отделение, пациент **[име на пациента, протокол №]**: на ехографията на корема виждам **[илеоколна]** инвагинация.
А · АНАМНЕЗА	Изпратен поради интермитентна болка в корема и повръщане.
О · ОЦЕНКА	**[В десния корем]** образ на мишена; кръвоток в стената **[запазен/намален]**, свободна течност **[няма/има]**.
П · ПРЕПОРЪКА	Препоръчвам спешна оценка от детски хирург.

Запис в описанието: «**[Илеоколна]** — находки, съответстващи на инвагинация. Спешна находка; **[час]**: **[длъжност, отделение]** — лекарят е уведомен.»

ЧАСТ 5

Какво се записва в описанието

Съобщаване, което не е записано, не може да бъде проверено по-късно.

ЕЛЕМЕНТ	ПРИМЕР
Какво е съобщено	Критичната находка от заключението, със същите думи като в описанието.
Час	«в [час]» — ако датата не личи от самото описание, посочете и нея.
На кого	Длъжност и отделение: «дежурен лекар в спешното отделение», «лекар, отговорен за [отделение]». Дали да се пише име, зависи от практиката във Вашата институция.
По какъв начин	По телефона / лично.
Потвърждение	«Информацията е потвърдена чрез повторно прочитане.»

Модел на изречението за запис

«[Находка]. [Час]: [длъжност, отделение] — лекарят е уведомен по телефона, информацията е потвърдена чрез повторно прочитане.»

ЧАСТ 6

Трудни ситуации

Телефонът не винаги се вдига от първия път.

СИТУАЦИЯ	КАКВО ПРАВИТЕ
Не можете да се свържете с лекаря, издал направлението	Свържете се с лекаря, който в момента отговаря за пациента, или с дежурния на отделението; следвайте реда за ескалация във Вашата институция. Запишете опитите и часовете им; уведомете Вашия ръководител.
Отсрещната страна вече знае за находката	Въпреки това съобщете накратко и запишете като «потвърдено като известна находка»; посочете изрично промяната спрямо предходното изследване.
Не сте сигурни в находката	Не забавяйте съобщаването; веднага се консултирайте с Вашия ръководител. Посочете ясно степента на сигурност и по телефона: «в полза на», «съмнение за».
Разговорът се проточва или преминава в спор	Върнете се към четирите стъпки, повторете препоръката и включете Вашия ръководител. Клиничното решение принадлежи на клиничния екип; Вашата задача е находката да бъде предадена точно и навреме.
Предварително описание при нощно дежурство	Критичната находка се съобщава и записва по същия начин и в предварителното описание; ако след окончателното описание има промяна, тя се съобщава отново.

С образователна цел. Този материал не замества обучението по специализация, супервизията, клиничната преценка или описанието от специалист.

Следваща стъпка

Сега се върнете към Основен материал · 120 шаблона за готови описания. Попълнете изреченията за съобщаване в полето Заключение на шаблоните за спешни находки по модела за запис от този раздел.

За всички заключения при спешни находки можете да погледнете в **Бонус 1 · Банка от 200 заключения**— изреченията с етикет «Спешно».